

04 - 04- Cancers de l'endomètre - Pr. Soummani

(0:00 - 0:25)

Donc, on va parler un peu de la cancérologie gynécologique et mammaire. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait un cours de cancérologie en gynéco ? Le sein ? Le col ? Pas cher ? Ah, vous l'avez fait là ? Donc, on va faire les deux. On va faire le cancer de l'endomètre et le cancer de la bulle.

(0:25 - 0:35)

Pour moi, j'ai les deux. Et puis, on a la maladie trophoblastique gestationnelle. Donc, qu'est-ce que c'est les cancers ? C'est plusieurs cancers.

(0:35 - 1:02)

Les cancers de l'endomètre. Vous voyez ici, j'ai simplifié un peu, parce qu'il y a les cancers du corps de l'utérus. Et si vous trouvez quelque part les cancers du corps de l'utérus, vous allez trouver qu'il y a les cancers de l'endomètre, il y a les cancers du myomètre, le sarcome surtout.

(1:03 - 1:22)

Donc, c'est un peu plus vaste. Les cancers de l'endomètre, c'est toute prolifération tumorale maligne qui prend naissance au niveau de l'endomètre. Donc, le point de départ, c'est la cavité de l'utérus et pas le myomètre.

(1:22 - 1:46)

Donc, on va exclure tout ce qui est cancer du myomètre, surtout le sarcome, parce qu'en général, ils sont rares. Donc, toute prolifération tumorale maligne qui prend naissance à partir de l'endomètre, tout simplement. D'emblée, il faut savoir que c'est une pathologie de la femme âgée.

(1:47 - 2:08)

Donc, c'est une pathologie de la femme ménopausée. Mais ça n'exclut pas le fait qu'il y a une vingtaine de cas qui surviennent avant la ménopause. Donc, c'est surtout la femme âgée ménopausée, mais également chez la femme jeune.

(2:09 - 2:33)

Actuellement, on fait le dépistage, même au Maroc maintenant, pas dans tous les sites, mais quelque part dans les CHU, je pense. Le dépistage se fait en général par l'échographie endovaginale. Lorsqu'il y a une épaisseur élevée de l'endomètre, on fait une hystéroscopie pour voir ce qu'il y a à l'intérieur.

(2:33 - 2:51)

Comme ça, on va dépister les cancers à un stade précoce ou bien à un stade préinvasif, avant l'installation de l'invasion. Donc, le pronostic en général n'est pas mauvais. Ce n'est pas comme l'école.

(2:51 - 3:10)

Le pronostic, c'est en général tous stades confondus, c'est la survie à 5 ans et de 80 %. Donc, voilà un peu les objectifs. C'est un cancer de la femme 10 à 16 pour 100 000 femmes en France. On n'a pas de statistiques.

(3:11 - 3:38)

Pour l'American Cancer Society, c'est 361 000 cas par an. Si vous voyez avec 340 millions d'habitants, si on prend la moitié pour les femmes, c'est assez fréquent. Mais ça reste toujours moins fréquent que le cancer du col de l'utérus, surtout chez nous.

(3:38 - 4:08)

Chez nous, en général, le sein d'abord, le col, puis l'ovaire, l'endomètre et la vulve en dernier. Mais il faut savoir une chose, c'est que nous avons dit que c'est un cancer de la femme âgée, de la femme inopposée. Actuellement, il y a longtemps, l'espérance de la femme marocaine dépasse 50 ans.

(4:08 - 4:24)

49-50 ans maintenant, on est à 72 ans. Donc plus l'espérance de vie augmente, plus on aura affaire à des cancers de l'endomètre. Comme par exemple le cancer de la prostate chez l'homme.

(4:25 - 4:38)

Plus on avance dans l'âge, plus l'espérance de vie augmente, plus on a un risque élevé de faire un cancer de prostate. Pratiquement la même chose. Donc c'est la femme inopposée, l'âge moyen c'est 60 ans.

(4:39 - 5:00)

La tranche d'âge la plus touchée c'est entre 50 et 60 ans. Ce que je vous dis, 20 à 25 % des cas surviennent avant la ménopause. Faites attention, ce n'est pas parce que la femme est en période d'activité génitale que vous allez éliminer systématiquement le cancer de l'endomètre.

(5:00 - 5:33)

Non, ça existe même avant la ménopause. Les facteurs de risque, il y a toujours la même chose, le statut hormonal, l'hyper-œstrogénie absolue ou relative, on a parlé de ça. Soit une tumeur sécrétante, soit des traitements œstrogéniques, par exemple le traitement substitutif de la ménopause, c'est des hormones, par conséquent ils peuvent augmenter les œstrogènes qui pourraient être à l'origine.

(5:33 - 6:11)

Il y a également l'hyper-œstrogénie relative, que ce soit la ménopause tardive ou la puberté précoce, c'est surtout aux extrêmes d'âge, il y a en général une présence lutéale explique l'hyper-œstrogénie relative. On a expliqué ça avec relative absolue. Et puis il y a le terrain, le terrain il y a l'obésité, l'obésité parce qu'il y a le stront qui provient de la masse grasseuse, nous avons parlé de ça, c'est la même chose.

(6:12 - 7:31)

Il y a la nulliparité, en général les femmes qui font un cancer de l'endomètre sont des nullipares, ils ont une ménopause tardive, ils ont une alimentation qui est riche en viande, en sucre, en œufs et pauvres en fruits et légumes, c'est la même chose quand tous les cancers mangent trop de fruits et légumes, mieux que la viande et les graisses, surtout les graisses animales. Et il y a quelques cas d'hérédité, vous connaissez le syndrome de Lynch, je pense que vous avez vu ça en viscérale, non ? Le cancer du sein, l'ouvert et l'endomètre en général, il y a cette association à caractère héréditaire, en général c'est le BRCA1, BRCA2, il y a le diabète, l'hypertension. Le diabète et l'hypertension on ne sait pas, est-ce que c'est parce que c'est une femme âgée ménopausée ? En général les femmes âgées, les patients hommes et femmes âgées ont plus de diabète type 2, ont plus d'hypertension artérielle, peut-être que c'est une simple coïncidence.

(7:32 - 8:09)

Et puis il y a le Tamoxifène, ça il faut le connaître, qu'est-ce que c'est le Tamoxifène ? C'est un anti-œstrogène, on le donne en général pour le traitement hormonal du cancer du sein. Lorsque la femme a un cancer du sein, on fait un traitement et après on donne le Tamoxifène pendant 2 à 5 ans. Les femmes sous Tamoxifène, il faut les surveiller parce qu'ils développent plus un cancer de l'endomètre.

(8:09 - 8:40)

On verra, en général on fait une endoscopie, une écho-endovaginale et on mesure l'épaisseur de l'endomètre. Voilà les facteurs de risque. L'obésité, le risque relatif est élevé, la nulliparité, la ménopause tardive, l'hypertension artérielle, la puberté précoce, le diabète, l'exposition aux œstrogènes seules.

(8:40 - 9:03)

C'est l'hyper-œstrogénie absolue. En général, lorsqu'on donne des œstrogènes, il faut toujours les associer à la progestérone pour combattre l'effet d'œstrogène. Il y a le Tamoxifène, les ovaires polycystiques, on n'a pas d'idée, on ne sait pas.

(9:03 - 9:28)

La contraception orale, les femmes sous contraception orale pendant la période d'activité génitale développeraient au conditionnel moins de cancers de l'endomètre. Le tabac, le risque relatif est inférieur à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque relatif lié au tabac. Parce qu'en général, les cancers de l'endomètre sont des cancers hormono-dépendants.

(9:29 - 9:42)

Ce n'est pas comme le cancer du col ou le tabac incriminé. Pas incriminé directement, mais indirectement. Donc voilà un peu ce que vous avez.

(9:46 - 9:53)

Ça, c'est la cavité de l'utérus là-bas. Ça, c'est l'endocole. Et ça, c'est le col de l'utérus.

(9:54 - 10:13)

Cette cavité est tapissée par un endothélium glandulaire. Si on prend une partie, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver ici le myomètre. Ici, c'est la couche basale.

(10:13 - 10:24)

La couche basale de l'endomètre ne fonctionne pas, elle est toujours là. C'est la couche spongieuse et la couche compacte. Ces deux constituent la couche fonctionnelle.

(10:25 - 10:39)

C'est cette couche qui suit l'évolution du cycle hormonal. Elle se développe au cours du cycle et elle chute au cours des règles. C'est cette couche là, la couche compacte et la couche spongieuse.

(10:39 - 10:54)

La couche basale n'est pas fonctionnelle. Elle est toujours là parce que c'est ici où il y a les vaisseaux spiralés. En général, le cancer de l'endomètre prend naissance au niveau ici.

(10:57 - 11:10)

Sur le plan anatomopathologique, la macroscopie, vous pouvez la trouver. La macroscopie, c'est-à-dire qu'on fait un hystéroscope. Vous connaissez l'hystéroscope ? C'est comme le fibroscope.

(11:11 - 11:46)

On l'introduit au niveau de la cavité de l'utérus et on voit au niveau de... C'est un système optique avec caméra, avec un moniteur, et on voit la cavité de l'utérus. Ça peut être une végétation ou bien un polype, parfois un polype même banal, peut être un cancer de l'endomètre, ou bien un aspect polypoïde de l'endomètre. Également, ça peut être un cancer de l'endomètre.

(11:46 - 12:20)

N'importe quelle lésion au niveau de l'endomètre peut être un cancer, tout simplement. Chaque fois que vous faites l'hystérocopie, lorsque vous trouvez une lésion, ulcération, végétation, bourgeon, polype, aspect polypoïde, il faut faire du biopsy. Sur le plan histologique, le type histologique le plus fréquent, c'est un adénocarcinome, parce que l'endomètre, c'est un endothélium glandulaire qui sticke.

(12:20 - 12:30)

C'est des glandes, surtout les deux couches fonctionnelles. Ça se multiplie. Donc, l'adénocarcinome, le plus fréquent, c'est l'adénocarcinome.

(12:30 - 12:41)

Dans le type adénocarcinome, il y a les sous-types. Il y a l'endométrioidé. L'endométrioidé, c'est un cancer qui rappelle le tissu normal de l'endomètre.

(12:42 - 12:53)

Il y a l'adénocarcinome séreux, l'adénocarcinome à cellules claires, l'adénocarcinome muscineux, l'adénocarcinome squameux. Là, il y a une composante épidermoïde. C'est pour ça qu'il y a de mauvais pronostics.

(12:54 - 13:05)

Et l'adénocarcinome indifférencié, en général, il a de très mauvais pronostics. Donc, l'endométrioidé, il est le plus fréquent. Et en même temps, il a de bons pronostics.

(13:07 - 13:36)

De toutes les manières qu'il y a un cancer, lorsque tu as un cancer qui reflète le tissu d'origine, c'est-à-dire qu'il est bien différencié, par conséquent, il a de bons pronostics. Moins il devient différencié, il devient de mauvais pronostics. L'adénocarcinome séreux, c'est pratiquement comme celui du cancer de l'ovaire.

(13:36 - 13:55)

L'adénocarcinome à cellules claires, comme le cancer du rein, ainsi de suite. Pour vous, l'adénocarcinome, c'est le type le plus fréquent. Et dans les sous-types, il y a l'adénocarcinome endométriode, qui a de bons pronostics et qui est le plus fréquent.

(13:55 - 14:35)

Et bien sûr, il y en a les autres types. Je ne vais pas parler des autres, je ne pense pas que c'est important pour vous. Il y a une classification histogénétique basée sur... C'est une classification histogénétique qui est basée sur des données cliniques et des données pathologiques, moléculaires ou génétiques.

(14:35 - 14:48)

Ils ont classé... Bon, retenez ça. Et puis, elle a beaucoup plus de retombées sur le traitement chirurgical. Vous voyez, donc pour vous, ce n'est pas ça le problème.

(14:48 - 15:08)

Le problème pour vous, c'est retenez que le type 1 est de bons pronostics et le type 2 est de mauvais pronostics. Tout simplement. Je n'ai pas compris.

(15:09 - 15:47)

Est-ce que vous entendez ça ? Vous entendez ? Ou est-ce que vous voyez ? Le type 1, c'est l'adénocarcinome endométriode. Comme vous le savez, comme l'adénocarcinome endométriode, celui qui est de bons pronostics, est l'adénocarcinome mucineux. C'est comme le carcinome mucineux de l'ovaire.

(15:48 - 16:01)

Il est de bons pronostics. C'est le type 1. Le type 2, c'est le carcinocarcombe. Le carcinocarcombe, il y a une composante endothéliale et une composante conjonctivale.

(16:01 - 16:15)

C'est pour ça qu'il est de mauvais pronostics. Parce que les carcombes, en général, sont de mauvais pronostics. L'adénocarcinome serreux, la cellule claire et le carcinocarcombe sont de mauvais pronostics.

(16:16 - 16:48)

L'endométriode et le mucineux sont de bons pronostics. Pour les retombées pathologiques, les retombées thérapeutiques, c'est compliqué. Voilà un peu la classification, le type 1 et le type 2. Le plus fréquent, c'est le type 1. Il est hormonodépendant.

(16:49 - 16:55)

Ici, il n'est pas hormonodépendant. Après, la périménopause. Ici, c'est la postménopause, l'hyperplasie atypique.

(16:56 - 17:00)

Ainsi de suite. Le grade histopronostique, c'est bas. Ici, c'est élevé.

(17:00 - 17:05)

L'invasion myométriale, etc. Ça, c'est pour vous. Ce n'est pas pour eux.

(17:07 - 17:13)

Voilà un peu. Ça, c'est l'endomètre. Ici, il y a des fibromes, etc.

(17:13 - 17:26)

Mais ici, il y a une lésion. C'est la coagulation des fibromes de l'utérus pour vous dire que si vous avez des lésions, faites attention. Le fibrome passe en deuxième position.

(17:28 - 17:34)

C'est surtout le cancer. Parce que le cancer tue. Le fibrome ne tue pas.

(17:36 - 17:41)

Voilà un peu. Ça, c'est un aspect polypoïde. Regardez ici.

(17:41 - 17:48)

C'est comme un polype bénin. Mais si vous faites la biopsie, vous pouvez trouver que c'est un cancer. Donc, il faut faire attention.

(17:49 - 17:59)

Sur le plan de l'extension, d'abord, l'extension est locale. Elle se fait en surface. Et elle se fait en profondeur.

(18:00 - 18:19)

Également, pour nous, on prend en considération surtout en surface. Lorsqu'il atteint l'isme ou l'endocole, il devient étendu parce qu'il peut envahir les vaisseaux. Il peut envahir les lymphatiques.

(18:20 - 18:41)

Mais s'il reste au niveau de la cavité superficielle, ce n'est pas grave. En profondeur, lorsqu'il atteint le myomètre, lorsqu'il dépasse les 50 % du myomètre, il envahit les lymphatiques. Donc, vous voyez, il y a un envahissement superficiel qui peut aller vers l'endocole ou l'isme.

(18:42 - 18:57)

Il y a l'extension profonde qui va aller vers le myomètre. Régionale, c'est les paramètres, l'annexe, la viscée, le rectum, etc. Et les métastases à distance, c'est les lymphatiques, surtout s'il y a atteinte de l'isme et le myomètre.

(18:58 - 19:04)

Et des métastases vaginales, foie, poumon, comme tous les cancers. Voilà un peu. Regardez ici.

(19:05 - 19:11)

Vous voyez, ça, c'est la cavité de l'utérus. Le voilà. Et vous voyez, ça, c'est la tumeur.

(19:11 - 19:18)

C'est une tumeur qui est bourgeonnante. La voilà. Et cette tumeur, elle va aller envahir.

(19:19 - 19:32)

Déjà, elle est superficielle et elle va aller envahir le myomètre. Donc, ça, c'est le cancer de l'endomètre. Bon, rapidement, quels sont les signes fonctionnels ? C'est une femme.

(19:32 - 19:48)

Donc, on va prendre comme type de description le cancer de l'endomètre de la femme ménopausée. Parce que c'est le plus fréquent. C'est une femme qui va le plus souvent vous consulter pour des métroragies.

(19:50 - 20:02)

Des métroragies chez une femme ménopausée. Chaque fois qu'il y a une femme ménopausée qui fait des métroragies, c'est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Retenez ça.

(20:03 - 20:33)

Mais bien sûr, avant de sauter sur l'histologie, etc., vous allez demander à la femme est-ce qu'elle prend des médicaments ? Parce que les médicaments à base d'œstrogène vont saigner. La femme va saigner. La femme de 80 ans, si vous lui donnez un œstrogène, vous arrêtez l'œstrogène, elle va saigner.

(20:33 - 20:49)

Donc, vous allez faire votre interrogatoire pour éliminer une cause exogène d'œstrogène. Mais toute métrorragie post-ménopausée est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Ce sont des métrorragies qui sont spontanées.

(20:49 - 21:08)

Ce sont des métrorragies qui sont spontanées, c'est-à-dire qui ne sont pas provoquées. Vous avez fait le cancer du col de l'utérus. Dans le cancer du col de l'utérus, les métrorragies sont surtout des métrorragies provoquées par un rapport sexuel, par les toilettes intimes, etc.

(21:09 - 21:16)

C'est-à-dire parce qu'il y a une tumeur, on la touche, elle saigne, tout simplement. C'est le col. L'endomètre, c'est à l'intérieur.

(21:17 - 21:25)

Donc, ce sont des métrorragies qui sont spontanées. En général, ils sont indolores. S'il y a de la douleur, ça veut dire que c'est un cancer qui a évolué.

(21:26 - 21:43)

Donc, ce sont des métrorragies spontanées, indolores. Elles sont faites de sang rougeur. Ça, c'est le signe fonctionnel le plus important.

(21:43 - 21:50)

Il y en a d'autres signes. Il y a les hydorrhées, il y a les leucorrhées, il y a la pyométrie. Ça, c'est important.

(21:50 - 22:10)

La pyométrie, c'est quoi ? C'est une femme qui est ménopausée depuis 10-15 ans. Quand elle a pratiquement une stenose du col de l'utérus, elle va développer un cancer à l'intérieur de la cavité. Lui, il va saigner, il va s'écarter de sécrétions, il va se surinfecter.

(22:11 - 22:26)

Donc, il y aura du pus. Ce pus ne peut pas descendre, donc il va rester au niveau de la cavité de l'utérus. Il va augmenter de volume et il va se comporter comme une poche remplie de pus, comme un nabzé.

(22:26 - 22:41)

Donc, la femme aura les signes d'une infection profonde, la fièvre, la douleur, etc. Vous faites

l'échographie, vous allez trouver que l'utérus est rempli d'un liquide hétérogène. Peut-être que vous allez trouver la tumeur, etc.

(22:42 - 22:55)

C'est la pyométrie. Un peu avancé, vous allez trouver des troubles physiques, des troubles rectaux. Ça, c'est parce qu'il y a l'invasion.

(22:55 - 23:09)

Et puis, vous aurez la douleur dû à l'envahissement, surtout des filets nerveux périphériques. Vous allez trouver tout ça. Donc, le plus souvent, c'est des météorologies.

(23:10 - 23:27)

Toutes les météorologies chez la femme âgée, ménopausée, imposent un bilan. Chaque fois que vous trouvez une femme ménopausée qui fait des météorologies, il faut faire un bilan. Obligatoire.

(23:28 - 23:45)

Le bilan, on va voir que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On différencie toujours entre le bilan diagnostique et le bilan d'extension. Ce sont des choses qui sont différentes.

(23:46 - 24:15)

Donc, vous allez faire votre examen, l'interrogatoire, les facteurs de risque, d'abord. Deuxièmement, c'est une femme âgée, elle peut être diabétique, elle peut être hypertendue, elle peut présenter une insuffisance respiratoire, peu importe, elle peut présenter une TAR associée. Donc, le terrain, c'est important dans le cancer de l'endomètre parce que parfois, il nous empêche de faire le traitement qu'il faut.

(24:16 - 24:40)

Dire, bon, je vais opérer cette femme, mais la femme a 80 ans, elle est diabétique, elle est hypertendue, elle a peut-être un problème cardiaque, une sténose d'une artère coronaire, etc. Elle peut mourir par l'intervention. Donc, on préfère faire des gestes à minima pour ne pas tuer la femme, tout simplement.

(24:40 - 25:03)

Donc, il faut chercher les facteurs de risque et les TAR associés. Et puis, vous faites votre examen, l'examen somatique d'abord, et l'examen, après l'examen aux spéculums, le col est sain, il n'y a pas de cancer du col, le saignement provient de la cavité de l'utérus, et parfois, vous trouvez que le cancer a déjà envahi le col ou le vagin. Donc, vous allez trouver des métastases

au niveau du vagin.

(25:05 - 25:22)

Le toucher vaginal, en général, ce sont des femmes qui sont obèses, ce sont des femmes qui ont une atrophie vaginale, vu qu'elles sont monoposées depuis longtemps, donc l'examen ne va pas être facile. La femme va avoir de la douleur, etc. Il faut être très, très doux.

(25:23 - 25:38)

Le plus souvent, on remplace le toucher vaginal. Pour moi, mieux chez les femmes âgées, de faire un toucher rectal qu'un toucher vaginal, ou un toucher vaginal avec un seul doigt. C'est moins douloureux, et ça donne pratiquement la même chose.

(25:40 - 26:02)

Donc, si vous avez de la chance, vous allez trouver qu'il y a un utérus qui a augmenté de taille, tout simplement. Mais le plus souvent, l'examen clinique est pratiquement normal. Donc, par le toucher rectal, vous pouvez également voir, pas uniquement l'augmentation de volume de l'utérus, mais également, vous pouvez toucher les paramètres.

(26:03 - 26:15)

Ils sont mieux explorés, les paramètres, par le toucher rectal que par le toucher col. Le cancer du col. Les paramètres sont mieux explorés par le toucher rectal que par le toucher vaginal.

(26:17 - 26:31)

Donc, mais l'examen le plus souvent est normal. Donc, au total, une femme ménopausée qui présente des météorologies, même si l'examen clinique est tout à fait normal, il faut faire un bilan. C'est obligatoire.

(26:32 - 26:55)

Le bilan des examens complémentaires, c'est la même chose. L'ascitologie, bon, qu'est-ce que ça veut dire l'ascitologie? Le frottis cervico-vaginal, ce n'est pas un cancer qui descohame. Ce n'est pas comme le carcinome épidermo-éducol de l'utérus qui descohame ou le frottis peut montrer des cellules atypiques.

(26:55 - 27:04)

Ici, il ne descohame pas. Par conséquent, le frottis cervico-vaginal est souvent normal. Vous pouvez faire un frottis endo-utérin.

(27:05 - 27:12)

On le fait peu. Avec l'hystéroscopie, on le fait peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On prend une petite brosse.

(27:15 - 27:34)

Les brosses avec lesquelles vous faites le nettoyage des biberons. Bien sûr, c'est terrible. On les met à l'intérieur de la cavité de l'utérus.

(27:34 - 27:50)

On fait des mouvements de rotation et on tire la brosse. On l'envoie chez le cytopathologiste pour voir s'il y a des cellules cancéreuses emprisonnées dans les filaments de la brosse. C'est ça.

(27:50 - 28:03)

Mais en général, ce frottis endo-utérin n'a de valeur que s'il est positif. Si vous trouvez des cellules cancéreuses, c'est OK. Si c'est normal, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un cancer.

(28:04 - 28:16)

L'histologie, on peut faire une biopsie de l'endomètre par une sonde qu'on appelle la sonde de Novak. Retenez la biopsie de l'endomètre. On introduit la sonde et on gratte à l'aveugle.

(28:16 - 28:38)

On peut faire un curetage biopsique. Comme le curetage avec la curette, on fait un curetage de tout l'endomètre qui ramène du tissu et on l'envoie à l'anapathe pour voir s'il n'y a pas un cancer. Mais maintenant, c'est l'hystéroscopie.

(28:40 - 29:01)

Maintenant, l'hystéroscopie, en général, c'est très fin, c'est 7 millimètres, c'est très fin, ne nécessite pas d'anesthésie générale, il ne nécessite que de l'anesthésie locale. Il se fait en ambulatoire, donc la femme n'est pas obligatoirement hospitalisée pour faire ça. Vous introduisez l'hystéroscope.

(29:04 - 29:17)

Il y a deux types d'hystéroscope. Il y a l'hystéroscope diagnostique, c'est lui qui a 7 millimètres. L'hystéroscope opératoire, il a 10 millimètres, un centimètre.

(29:17 - 29:52)

C'est pour pouvoir mettre l'aisance, etc., pour réséquer la pince, le ciseau, etc. Ça, c'est l'hystéroscope diagnostique. Il se fait en ambulatoire, il va vous permettre de voir la lésion, il va

vous permettre de faire la biopsie, et il va vous permettre de voir est-ce qu'il y a un envahissement en surface, c'est-à-dire est-ce qu'il y a l'atteinte de l'isme, est-ce qu'il y a l'atteinte de l'endocolle, ça veut dire que les ganglions sont envahis.

(29:52 - 30:16)

Donc, c'est ça qu'il va vous montrer, l'hystéroscope diagnostique. Après, vous avez vu que j'ai commencé par l'hystéroscope, parce que c'est nouveau pour vous. Alors qu'en général, on fait l'examen clinique, on termine par une échographie endovasionnelle.

(30:17 - 30:42)

Mais pour vous, l'échographie c'est la première fois, l'hystéroscope peut-être c'est la première fois, la première année, mais c'est la première fois. Le fibro-endocavitaire ou intracavitaire. L'échographie en général, chez une femme ménopausée, l'endomètre ne doit pas dépasser 5 mm.

(30:42 - 31:11)

Donc, si vous faites une échographie endovasionnelle et que vous trouvez que l'épaisseur de l'endomètre dépasse 5 mm, il faut faire une hystéroscopie. Mais l'échographie peut vous montrer un bourgeon tumoral intracavitaire qui est irrégulier. Si vous mettez du Doppler, vous allez trouver qu'il est richement vascularisé.

(31:12 - 31:30)

L'échographie va vous permettre de voir le degré d'envahissement de myomètre. Il va vous permettre également de voir s'il y a un envahissement de l'eau verte. Donc, voilà l'échographie.

(31:31 - 31:57)

Mais retenez surtout que cette échographie endovasionnelle, c'est-à-dire les femmes qui sont sous tamoxypènes, il faut la faire chaque an. Chaque an, la femme sous tamoxypènes, elle doit faire une échographie endovasionnelle chaque année. Sinon, toute femme endoposée qui a un endomètre au-delà de 5 mm, il faut faire une hystéroscopie.

(31:58 - 32:42)

L'ATDM, c'est surtout le bilan d'extension, mais actuellement, on fait beaucoup plus l'IRM parce que l'IRM va nous donner une coupe anatomique et on va voir la lésion, on va voir le degré d'extension en surface, le degré en profondeur vers le myomètre et le degré d'envahissement des organes de voisinage, voire même les métastases. Donc, l'IRM, c'est un examen très important pour le bilan d'extension. Donc, voilà quelques... Voilà, si vous voyez ici, vous avez la viscille, vous avez le vagin, vous avez le rectum et vous avez ici la tumeur, la voie là.

(32:43 - 33:09)

Donc, il envahit pratiquement tout le myomètre, même la graisse. Ce qui est en blanc ici, c'est ce qu'on appelle la graisse, la graisse utéroviscrale en général. On ne la voit pas, on la voit ici, vous voyez, mais on ne la voit pas ici, ça veut dire que probablement il y a un envahissement de la viscère.

(33:10 - 33:44)

Donc, voilà un peu ce que vous cherchez par l'IRM. Donc, le diagnostic différentiel, après la ménopause, bon, après la ménopause, il y a le cancer du col, de l'utérus, mais ça, vous pouvez rapidement l'éliminer parce que vous allez mettre votre spéculum et vous allez trouver que le col est normal. Mais le plus souvent chez la femme ménopausée, le col est aspiré, vous n'allez pas le voir et ça, on fait également une hystéroscopie pour voir l'onde au col.

(33:45 - 34:12)

L'atrophie de l'endomètre, un endomètre très atrophique, saigne également, pourquoi ? Parce que la femme ménopausée aura la couche basale, elle n'a plus la couche spongieuse et compacte, la couche fonctionnelle, elle n'en a plus, mais elle a la couche basale. Je vous ai dit que dans la couche basale, il y a des vaisseaux spiralés. Donc, lorsque c'est atrophique, ils vont s'ouvrir et la femme peut saigner.

(34:13 - 34:47)

Il y a l'endométrite hémorragique, ça existe, il y a le polype, mais le polype, en général, chez la femme ménopausée, c'est un cancer jusqu'à preuve du contraire. Mais attention, aucun de ces diagnostics après la ménopause ne doit être retenu qu'après l'élimination du cancer de l'endomètre. Est-ce qu'on est d'accord ? Donc, c'est le cancer de l'endomètre, et le reste, si vous n'avez pas trouvé, vous avez fait une co-endovaginale, l'endomètre n'est pas épais, il n'y a pas de bourgeon, il n'y a pas de tumeur, vous avez fait une hystéroscopie, la cavité de l'utérus est normale, etc.

(34:47 - 35:22)

C'est dans ce cas que vous allez retenir les autres types de diagnostics différentiels. Avant la ménopause, tout est permis. Un fibrome intracavitaire, un fibrome sous-muqueux, un cancer du col de l'utérus, une hyperplasie de l'endomètre, des métrorragies fonctionnelles, en général, les métrorragies fonctionnelles, c'est en rapport avec les hormones, les régularités du cycle menstruel.

(35:25 - 36:10)

Voilà, une forme clinique, je vous ai parlé de ça parce que c'est 20 à 25 %, c'est les formes de

cancers de l'endomètre avant la ménopause. En général, il survient entre 40 et 50 ans. Pourquoi ils sont de mauvais pronostics ? C'est d'abord parce que la femme ménopausée fait beaucoup plus les cancers de l'endomètre type 1 alors que la femme avant la ménopause fait le cancer de type 2, c'est-à-dire le séreux, le carcino-sarcome et la cellule claire, très bien.

(36:10 - 36:53)

Donc vous voyez, c'est parce que ce sont des cancers qui ne sont pas hormonodépendants comme l'adénocarcinome en général. Deuxième des choses, donc premièrement ça, ils font les types les plus graves, mais deuxièmement, vous savez que dans la période de la périménopause, la femme a une irrégularité du cycle, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un retard de règle de deux mois, trois mois, puis elle a des saignements pendant un mois, ainsi de suite. Lorsqu'elle va voir le gynécologue ou le médecin en général, le médecin de traitement, il ne fait pas attention.

(36:54 - 37:16)

Pour lui, c'est une irrégularité du cycle qui est très fréquente avant la périménopause, donc il va donner un traitement, etc. pour régulariser le cycle, etc. Donc faites attention lorsque vous avez une femme qui a une irrégularité du cycle, ne laissez pas ce progestatif pendant longtemps alors qu'elle saigne toujours.

(37:16 - 37:36)

Il faut faire un bilan pour pouvoir... Effectivement, ce n'est que les hormones qui sont en cause, ou bien elle a une lésion organique qui est en cause. Donc ça, ça fait le mauvais pronostic de la forme pré-ménopausique. Et deuxièmement, une deuxième forme clinique, c'est le polype sentinelle.

(37:36 - 37:54)

Le polype sentinelle, c'est un polype qui existe au niveau du col de l'utérus. On le voit en consultation, en spéculant, on voit le polype. Il est appelé sentinelle ou un gardien, un militaire, un gardien de caserne, ou un sentinelle.

(37:55 - 38:12)

En général, on fait un bistournage, on l'enlève, mais faites attention lorsque vous avez un polype, vous enlevez le polype et vous faites un bilan pour éliminer un cancer oscillé au niveau de la cavité de l'utérus. C'est très fréquent également. Donc ce sont les deux formes cliniques.

(38:12 - 38:46)

Il y en a d'autres, mais ce sont les plus fréquents, les formes les plus fréquentes que vous allez

rencontrer. Bon, le bilan préthérapeutique, l'examen clinique, on fait un examen sous anesthèse générale en général parce que la femme a un problème. En général, elle est obèse, le toucher vaginal est douloureux, donc on fait un examen clinique pélvien sous anesthèse générale avant de commencer le traitement.

(38:46 - 39:10)

On fait un examen somatique, donc généralement, ça c'est le bilan pré-anesthésique et le bilan, en général, fait par les anesthésistes et les animateurs. L'écho-ondovaginale, je vous ai dit qu'on peut voir les ganglions, les annexes, l'enveillessement du myomètre. L'UV, on ne la fait pas puisqu'on commence à faire l'IRM.

(39:10 - 39:29)

L'IRM, c'est surtout ça pour la pénétration myométriale et pour la découverte d'adhéropathie. Et vous aurez votre classification, il est là. J'ai mis ça parce que c'est plus intéressant avec des photos.

(39:30 - 39:40)

Vous pouvez dessiner ça. Le stade 1, il est limité au corps de l'utérus. 1A, c'est là, c'est ça.

(39:40 - 39:59)

Elle est superficielle, elle est moins de la moitié, moins de 50% de myomètres qui sont envahis. Et 1B, lorsque vous avez un envahissement de plus de 50%. 1, limité au corps de l'utérus.

(39:59 - 40:12)

2, il y a une atteinte, c'est là, une atteinte de col. Vous voyez la tumeur qui va vers le col de l'utérus. Parce que j'ai dit que lorsque vous êtes au niveau de l'isthme, au niveau du col, il y a probablement un envahissement ganglionnaire.

(40:12 - 40:36)

C'est le stade 2. Le stade 3, c'est l'extension au-delà du corps de l'utérus. C'est surtout, le 3A, c'est la serreuse, l'atteinte de la serreuse, de myomètres, on la voit ici. Vous voyez, regardez là, le 1B, c'est au-delà de 50% de myomètres qui sont envahis.

(40:37 - 40:58)

Le 3A, c'est lorsque toute la paroi, même la serreuse, de myomètres est envahie. Ça, c'est le 3A. Le 3B, c'est l'envahissement vaginal, c'est le 3B.

(40:58 - 41:11)

Et le 3C, c'est les métastases ganglionnaires. C'est un, c'est deux, c'est bien, on voit aussi. Le 3C, c'est l'évasion.

(41:12 - 41:31)

Et le 4, c'est l'extension de la viscille, du rectum et l'extension à distance. Ça, c'est les différentes évolutions du concept de l'endormissement. Bien sûr, pour nous, c'est important parce qu'à chaque stade, il y a un traitement particulier.

(41:42 - 41:57)

Donc, l'évolution et les complications. Bon, son traitement, la perle va continuer à saigner, la tumeur va s'infecter et la tumeur va évoluer. Donc, elle ne va pas disparaître seule.

(41:58 - 42:11)

Avec le traitement, il y a également le problème. C'est le problème du terrain. Donc, le traitement peut être peut être un geste qui ne correspond pas au stade.

(42:13 - 42:28)

Tu ne peux pas faire une pelvictomie chez une femme de 80 ans, obèse, cardiaque, hypertendue. Vous voyez ? Donc, il y a le risque de récurrence ou l'échec du traitement. Plus un échec qu'une récurrence.

(42:28 - 43:45)

Il y en a les deux. Mais également, le traitement peut être dangereux pour la femme parce qu'il y a les complications thromboemboliques, il y a les complications infectieuses. Il y a les complications dues à la chimiothérapie.

C'est un visage donné de la chimiothérapie. Dues à la radiothérapie, c'est un visage traité par la radiothérapie et ainsi de suite. Voilà les facteurs pronostiques.

Ça, c'est important à connaître parce qu'en général, lorsqu'on est médecin généraliste, on devrait surveiller une femme qui a présenté un cancer. Je peux la traiter et après la fin du traitement, j'écris un rapport de tout et je l'envoie à son médecin traitant pour la surveillance. Pour ne rien faire, pour faire un examen clinique tout simplement, ou bien faire une échographie alors qu'il peut faire ça chez elle.

C'est comme ça que ça doit être. Comme ça, on donne de la valeur au médecin généraliste qui, malheureusement, ne s'installe que sur le périphérique des villes. Ce n'est pas méchant, mais on aurait bien aimé l'installation même à côté de nous.

(43:47 - 44:06)

Une femme qui habite à Marrakech, s'il est suivi pour cancer, il ne va pas voir le médecin généraliste. Il ne voit que le spécialiste. Alors que le spécialiste, oui, lorsqu'elle doit être traitée, oui, mais une fois le traitement est terminé, la surveillance, on verra la surveillance, elle peut se faire par un médecin généraliste.

(44:08 - 44:25)

Le problème de l'âge, c'est un facteur pronostic. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire. C'est l'âge et l'opérabilité de la femme jouent un rôle, parce que vous pouvez ne pas traiter correctement parce que la femme est âgée et elle présente un tard associé.

(44:25 - 44:58)

Le stade de la figueau, c'est naturel, est le grade de différenciation. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le type 1 et le type 2. Le type 1, l'adénocarcinome et le carcinome mycineux sont de bons pronostics, les autres sont de mauvais pronostics. Donc voilà un peu le stade 1, c'est jusqu'à plus de 75% de survie à 5 ans.

Le stade 2, déjà vous tombez à la moitié, ainsi de suite. Le stade 4, c'est pratiquement 10% de survie. Donc vous voyez, voilà un peu.

(45:00 - 45:38)

Bon, ça, c'est pour vous expliquer un peu. Vous allez trouver ça dans les bouquins maintenant, parce que même le traitement, la discussion, les réunions pluridisciplinaires, on se base sur ça pour les facteurs pronostiques du cancer. Les stades localisés, vous voyez, c'est un stade localisé mais lorsqu'il y a un C, un 1C et trois grades histopronostiques et deux B sont de hauts risques.

(45:39 - 45:57)

Le risque intermédiaire, le bas risque, c'est le type 1, il y a un A ou un B, mais pour vous, on a les facteurs de risque. Stade lafigo, le grade histopronostique, les embouts, le type histologique, le type 1 ou le type 2, et l'âge. Voilà, c'est ça.

(46:00 - 46:33)

Pour le reste, c'est plus compliqué pour vous. Actuellement, on ne prend pas de décision seule. La cancérologie, c'est l'affaire de plusieurs spécialistes.

Pas uniquement le chirurgien cancérologue, gynécologue ou le radiothérapeute ou l'oncologue, etc. C'est tout le monde, y compris le radiologue, l'anapath, psychologue, etc. Le traitement, je vais parler beaucoup plus de ça.

(46:34 - 46:51)

La chirurgie, et puis c'est ce qui est important. La chirurgie, vous pouvez faire ça, c'est les moyens thérapeutiques, une ADNO, colpo, hystérectomie, élargie, équivé. ADNO, c'est le curage gonglionnaire.

(46:56 - 47:07)

ADNO, c'est le curage gonglionnaire. Colpo, c'est la colpectomie, c'est-à-dire une transvaginale. En général, elle est recommandée de centimètres.

(47:09 - 47:19)

Une transvaginale, colpectomie, colpo. Hystérectomie, c'est hystérectomie. Élargie, c'est les paramètres.

(47:19 - 47:35)

Donc, c'est une ADNO, colpo, hystérectomie, élargie. Bien entendu, chaque fois que la femme a un cancer de l'endomètre, un ADNO carcinome, il faut faire une ovariectomie bilatérale. C'est obligatoire.

(47:36 - 47:44)

Même si c'est une femme ménopausée. On doit enlever les ovaires. Donc, premièrement, l'ADNO, colpo, hystérectomie, élargie, c'est OK.

(47:46 - 48:00)

Deuxièmement, l'hystérectomie totale sans conservation anexiale. L'hystérectomie totale, vous voyez, pas de curage non glionnaire, pas de colpectomie, elle n'est pas élargie aux paramètres. Vous n'enlevez que l'utéruse avec le col et les ovaires.

(48:00 - 48:15)

Sans conservation des annexes, c'est les ovaires et la trompe. Vous enlevez ça. La différence entre la première et la deuxième, c'est que la première se fait en 2h30, 3h, et la première et la deuxième se fait en 40-45 minutes, même moins.

(48:17 - 48:33)

La première, c'est carcinologique, la deuxième, c'est moins carcinologique. C'est en fonction de ça que vous allez discuter ce qu'il faut faire avec la femme. Mais également du terrain.

(48:34 - 49:06)

Est-ce que la femme présente une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, etc. Donc, voilà, ADNO, colpo, hystérectomie, élargie, hystérectomie totale sans conservation anexiale, la radiothérapie, soit exclusive ou bien associée à la chirurgie, l'hormonothérapie, les progestatifs et les antioscrogènes, la chimiothérapie, et bien sûr, le traitement adjuvant, le traitement de la douleur, le traitement de l'anémie, etc. Le traitement que vous pouvez donner.

(49:07 - 49:34)

Les indications, c'est pas la peine. Donc, vous voyez, c'est en fonction du stade et de l'opérabilité. Je ne vais pas vous parler de ça parce qu'actuellement, les indications se font en réunion de concertation pluridisciplinaire.

(49:36 - 49:44)

On ne prend pas la décision seule. Il faut qu'il y ait un staff qui va prendre la décision. Et là, il y a le réanimateur.

(49:44 - 49:58)

Attention, c'est une femme qui présente ou qui a une fonction cardiaque de 30%. Elle peut mourir sur la table opératoire. Donc, privilégiez beaucoup plus la radiothérapie que la chirurgie, ainsi de suite.

(49:58 - 51:08)

Donc, pour vous, l'indication se discute en staff de concertation ou la réunion de concertation pluridisciplinaire. Vous voyez, hystérectomie, adéno élargie, plus ou moins radiothérapie, etc. C'est pas la peine.

La surveillance, vous voyez ce que je vous ai dit, que tout le monde peut surveiller une femme qui est traitée pour un cancer. Le médecin généraliste ne peut pas traiter un cancer du col, de l'utérus ou du corps ou là du sein, mais il peut surveiller après. Il peut faire le diagnostic, il envoie, la femme est traitée, elle la suit après.

Donc, le traitement, c'est simple, l'examen clinique, vous demandez une IRM, une TDM, si vous avez quelque chose de pas normal à l'examen clinique, vous pouvez faire des protovaginaux, ils ne vont rien donner. En général, dans les deux premières années, c'est chaque six mois, après chaque année, c'est correct, ainsi de suite. Donc, voilà.

(51:09 - 51:10)

C'est ça.